

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE III
FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE
CONSTANTINE
SERVICE D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

COURS DE 04^{ém} ANNEE DE MEDECINE

Hernies hiatales :

PRESENTE PAR :DR. M. FERMAS

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2023/2024

PLAN :

I. Introduction :

- Rappel anatomique et physiologique :
- Définition :

II. Physiopathologie :

III. Symptomatologie :

IV. Diagnostic :

V. Traitement :

VI. Conclusion :

I. Introduction :

Le diaphragme est un muscle séparant la cavité abdominale de la cavité thoracique. Il peut être le siège de hernies (à travers l'orifice hiatal) ou de lésions traumatiques.

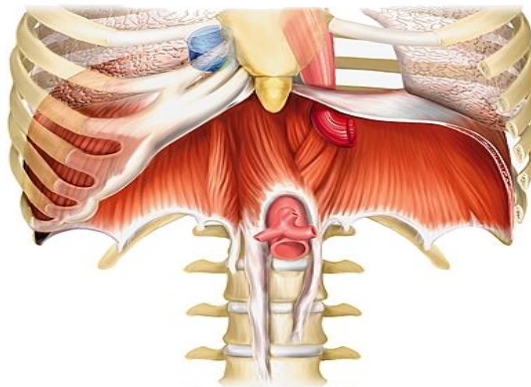
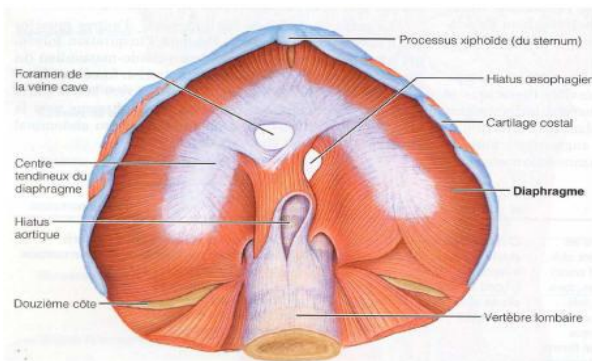
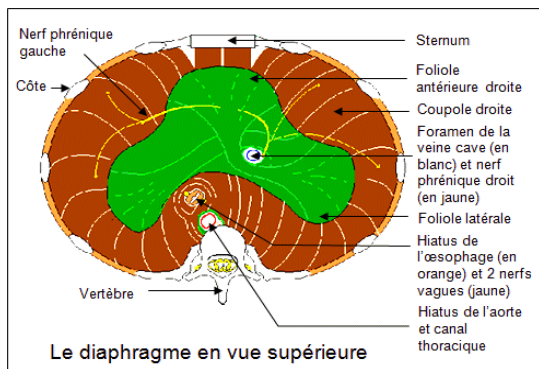
A. Rappel anatomique et physiologique :

1- Diaphragme : il est composé de 2 parties :

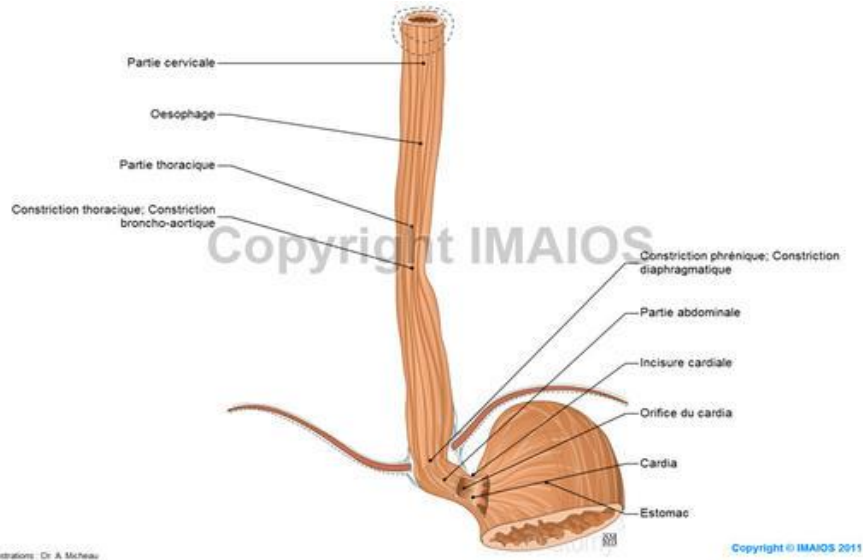
- **Périphérique : constituée de fibres musculaires charnues :**
 - La partie interne de la portion charnue est composée de 02 piliers du diaphragme (droit et gauche) et les 02 piliers en association avec le rachis lombaire constituent une large ouverture contenant 2 orifices : œsophagien (antérieur) et aortique (postérieur).
- **Centrale : constituée de 03 folioles en forme de trèfle, fibreuse et très résistante.**

2- Orifices diaphragmatiques : ils sont en nombre de 03 :

- Orifice de la veine cave inférieure, au niveau du centre phrénique.
- Orifice aortique, fibreux, médian.
- Orifice œsophagien, musculaire, mobile avec la respiration.
-

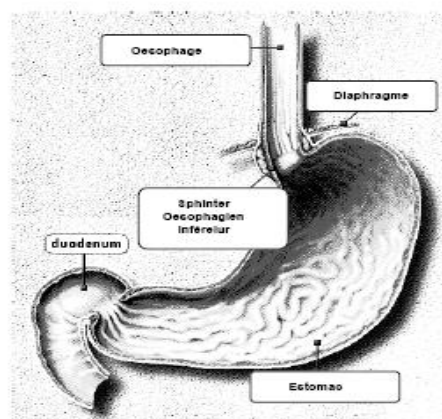


3- Œsophage abdominal : s'étend de l'hiatus jusqu'au cardia, sur environ 4 cm de longueur.



4- Estomac :

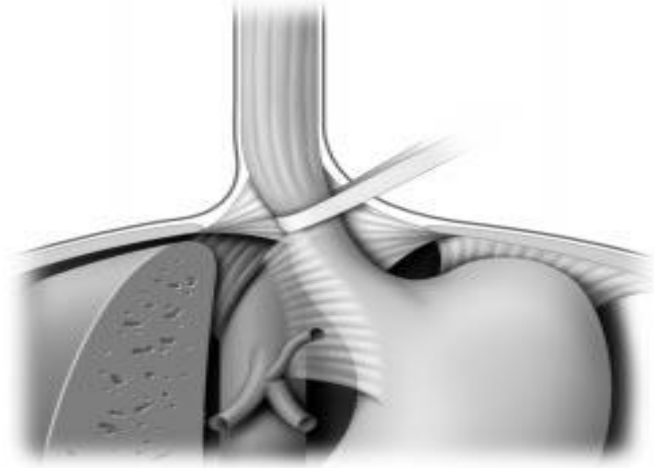
- **Cardia** : orifice ovalaire, oblique de haut en bas et de gauche à droite, entre l'extrémité supérieure de la petite courbure et la grosse tubérosité, présente le lieu d'abouchement de l'œsophage.
- **Angle de His** : se situe entre le bord gauche de l'œsophage et la grosse tubérosité, devenant aigu en cas d'estomac pleine.
- **Valvule de Gubaroff** : est un repli muqueux interne, à l'union des muqueuses œsophagienne et gastrique.



5- Continence gastro-œsophagienne : elle est assurée par le SIO en position intra-abdominale -, où la fixation est assurée par :

- Membrane phrénéo-œsophagienne.

- Mésocœsophage.
- Ligament gastro-phrénique (membrane phrénico-tubérositaire).
- Ligament gastro-splénique.



B. Définition :

La hernie hiatale se définit comme étant un passage permanent ou intermittent à travers l'orifice hiatal d'une partie de l'estomac, il existe 04 types :

- **Type 1 : Hernies par glissement :**

- C'est la hernie hiatale la plus fréquente, représente 85% des hernies hiatales.
- Elle ne possédant pas de sac herniaire.
- La jonction cardio-œsophagienne est en situation intra-thoracique avec disparition de la grosse tubérosité.
- Elle résulte de l'affaiblissement des moyens de fixation, en particulier la membrane phrénico-œsophagienne.
- La différence de pression entre l'abdomen et le thorax favorise alors l'ascension de la jonction œso-gastrique et de l'estomac vers le médiastin.
-



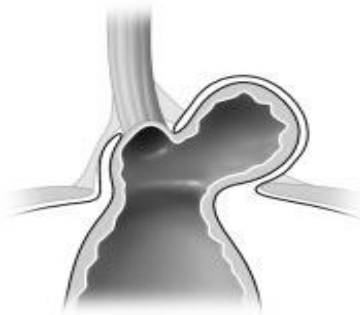
- **Type 2 : Hernies par roulement ou para-œsophagienne :**

- Elle est plus rare et représente 5% des hernies hiatales.

- Le cardia reste sous diaphragmatique mais la grosse tubérosité en intra-thoracique.
- Le sac herniaire est présent.
- Elle est secondaire à un élargissement de l'orifice hiatal et surtout de la déhiscence du ligament gastro-phrénique.
- Les complications sont représentées par :
 - « Les hémorragies par ulcérations muqueuses.
 - « Le volvulus gastrique et ses conséquences ischémiques.



- **Type 3 : Hernies mixtes (par glissement et roulement) :**
 - Le cardia et la grosse tubérosité sont en intra-thoracique.
 - Elles sont dues à une défaillance globale des moyens de fixité.
 - Elles ont les mêmes symptômes, les mêmes complications et les mêmes indications thérapeutiques, que ceux de la hernie par glissement.



- **Type 4 : Hernies avec un autre organe abdominal ascensionné dans le médiastin :**

II. Physiopathologie :

Certaines hernies ont clairement une origine congénitale secondaire à une fusion incomplète des deux rebords diaphragmatiques autour de l'œsophage. Le mécanisme est le même que pour d'autres hernies au niveau du diaphragme (hernie de Morgagni ou de Bochdalek) : un défaut de fusion des composantes diaphragmatiques laisse des ouvertures à travers lesquelles les viscères peuvent faire protrusion.

Cependant la grande majorité de ces hernies sont acquises et l'incidence augmente avec l'âge, surtout dans le cas de très grosses hernies. Le mécanisme d'affaiblissement progressif au niveau de la membrane phrénéo-oesophagienne, est favorisé par :

L'âge (une détérioration des différentes structures qui composent ce ligament avec le vieillissement), le surpoids, la grossesse, le travail physique, la toux chronique, l'asthme, la constipation chronique.

IV. Symptomatoologie :

A. **Hernies hiatales par glissement** : la clinique représentée essentiellement par la symptomatologie du RGO : le pyrosis, les régurgitations acides, douleurs épigastriques immédiatement sous xiphoïdienne, éructations, nausées, hoquet...ect.

B. **Hernies hiatales par roulement** : les maitres symptômes sont représentés par la **dysphagie** et le **ballonnement** postprandial. Ils sont causés par la compression de l'œsophage par le sac herniaire distendu, ou par la torsion de l'estomac qui se produit quand ce dernier se déplace dans le thorax.

On peut avoir également :

- Des douleurs, typiquement épigastriques ou rétrosternales.
- Un sentiment de pesanteur dans le haut de l'abdomen.
- Des crampes qui apparaissent pendant ou juste après le repas, elles sont parfois soulagées par des vomissements.
- Des symptômes respiratoires associés aux hernies para œsophagiennes :
 - La dyspnée, fréquente, est expliquée par un syndrome restrictif dû à la compression pulmonaire par un gros sac herniaire. Elle est fréquemment postprandiale.
 - Les pneumonies récurrentes sont plus rares. Elles peuvent conduire éventuellement à une fibrose pulmonaire. Elles sont attribuées à des régurgitations avec broncho-aspirations.
- L'anémie est retrouvée avec une fréquence qui varie entre 9% et 15%.

VII. Diagnostic : la confirmation des hernies hiatales se fait par les examens complémentaires suivants :

A. Radio standard du thorax : elle n'est pas une méthode de recherche spécifique de la hernie hiatale. Cependant elle peut permettre de révéler une hernie cliniquement muette, en montrant :

- l'image caractéristique du niveau hydro-aérique rétro-cardiaque, présente chez plus de 90% de patients avec un diagnostic de hernie hiatale.

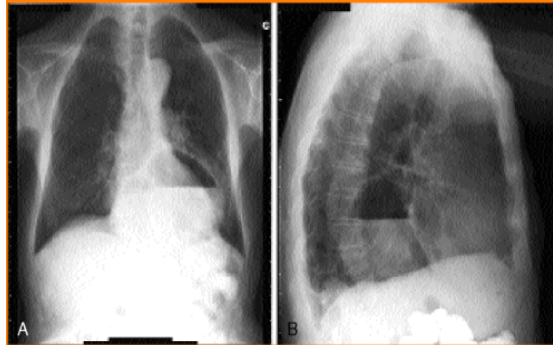
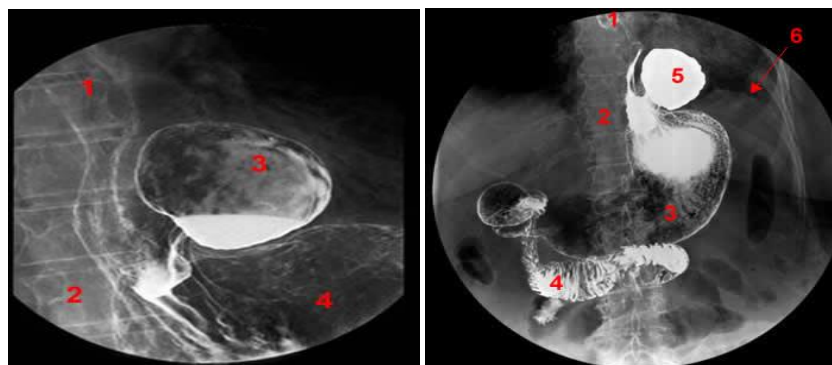


Fig. 4. Niveau hydro-aérique rétrocardiaque sur une radiographie standard du thorax.
A: face, B: profil.

B. Transit baryté oeso-gastro-duodénal en double contraste :

- Est l'examen de référence et permet d'affirmer le diagnostic.
- Lui seul permet de préciser le type anatomique de la hernie, sa taille, son contenu et sa réductibilité.
- En ce qui concerne la muqueuse et ses altérations, cet examen est par contre largement inférieur à l'endoscopie.
 - « Il peut cependant révéler des lésions (ulcères, tumeurs) lorsqu'elles sont importantes.
 - « Il est extrêmement sensible et précis pour les sténoses.
- Il donne enfin des notions fonctionnelles souvent utiles sur le péristaltisme du corps œsophagien, notamment sur son efficacité et sa propagation.



C. Fibroscopie digestive haute : a de nombreux avantages :

- visualise très précisément la muqueuse et permet de faire des biopsies.
- C'est un examen qui sera demandé pour démontrer, par exemple, une éventuelle œsophagite peptique dans le cadre d'un RGO, ou des ulcérations en cas d'anémie chronique.
- Par contre, cet examen ne permet que très imparfaitement d'apprécier exactement la taille et le type de la hernie.

D. TDM : elle peut également révéler une hernie hiatale non suspectée. Lorsqu'on suspecte une complication aiguë, elle est capable de la prouver et de participer à en établir la gravité. Elle est extrêmement utile pour affirmer ou exclure d'autres pathologies éventuellement responsables des symptômes.

E. Autres examens : la pH-métrie de 24 heures et la manométrie œsophagienne, indiquées en cas de RGO associée, si l'on envisage une intervention chirurgicale.

V. Traitement :

A. Buts :

- Soulagement des symptômes.
- Cicatrisation des lésions d'œsophagites sévères ou compliquées.
- Prévention des récives symptomatiques et des œsophagites sévères ou compliquées.

B. Moyens :

1. Traitement médical : voir cours RGO.
2. Traitement chirurgical : repose sur les interventions valvulaires :

L'opération comporte 04 temps :

1. La réduction de l'estomac dans l'abdomen.
2. Le calibrage de l'orifice hiatal autour de l'œsophage.
3. La confection d'un montage anti-reflux.
4. La fixation de l'estomac dans l'abdomen (gastropexie).

L'abord chirurgical peut se faire par laparotomie, laparoscopie ou thoracotomie.

Intervention de Nissen :

- Fundoplicature par la face postérieure de la grosse tubérosité ; circulaire totale (par un fil non résorbable).elle permet la fermeture de l'hiatus œsophagien (éviter l'ascension du montage anti-reflux).



Intervention de Toupet :

- Fundoplicature de 270° (face antérieure reste libre) :



Intervention de Nissen-Rossetti :

- Fundoplicature totale par la face antérieure du fundus, sans section des vaisseaux courts, cette dernière est à l'origine d'un taux important de dysphagie important.



C. Indications :

- * La réparation de la hernie hiatale type I n'est pas nécessaire en absence du RGO.
- * Toute hernie hiatale par roulement symptomatique doit être réparée en particulier celles qui présentent des symptômes obstructifs aigus ou celles compliquées d'un volvulus de l'estomac.
- * La réparation élective de routine d'une hernie hiatale par roulement complètement asymptomatique peut ne pas être toujours indiquée, et les considérations de chirurgie peuvent inclure l'âge et les comorbidités.

VI. Conclusion :

Les hernies diaphragmatiques sont dominées par les hernies hiatales par glissement, dont la cause est un affaiblissement des moyens de fixation, qui se voit souvent chez le sujet âgé.

Le traitement chirurgical n'a pas d'indication dans les hernies qu'en cas d'inefficacité du traitement médical dans les hernies hiatales par glissement.

La complication la plus redoutable en cas de hernies hiatales par roulement est le volvulus de l'estomac.

Les hernies hiatales et les pathologies diaphragmatiques chez l'enfant sont généralement en rapport avec des anomalies congénitales dont la solution est souvent chirurgicale.